Estações OSCE — Infectologia

10 estações · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#211** — Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas (oxiuriase)
2. **#280** — Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos (dengue com sinais de alarme)
3. **#281** — Ferida genital indolor há 2 semanas (sifilis adquirida)
4. **#282** — Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente (infeccao pelo hiv diagnostico inicial)
5. **#283** — Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente (leptospirose)
6. **#284** — Febre e dor articular intensa e incapacitante (chikungunya)
7. **#285** — Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia (malaria)
8. **#286** — Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí (doenca de chagas aguda)
9. **#287** — Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal (toxoplasmose gestacional)
0. **#288** — Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica (esquistossomose mansonica)

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #211 · UBS — Atenção Primária · nível simples

Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas

CENÁRIO

Atenção Primária — UBS. Consultório, turno vespertino. A mãe traz o filho para consulta.

PACIENTE

T.A.S., 7 anos, masculino, escolar, trazido pela mãe D.A.S., 32 anos. Sem comorbidades conhecidas.

QUEIXA PRINCIPAL

Mãe relata que o filho está com coceira intensa na região do ânus à noite há 3 semanas, dormindo mal e irritado.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida ao caso (com a mãe como informante principal).
2. Realize o exame físico pertinente na criança.
3. Formule a hipótese diagnóstica e solicite o exame confirmatório adequado.
4. Prescreva o tratamento correto para o caso.
5. Oriente a mãe sobre o tratamento de contatos domiciliares e as medidas preventivas.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #211 · UBS — Atenção Primária · nível simples

Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura	IMC
96/60 mmHg	88 bpm	20 irpm	36,5 °C	22 kg	1,20 m	15,3 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, consciente, orientado, levemente agitado durante o exame, corado, hidratado, sem icterícia.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: plano, RHA presentes, normofonéticos, sem dor à palpação, sem visceromegalias
- REGIÃO PERIANAL: escoriações perianais superficiais por coçagem; mucosa perianal discretamente eritematosa; sem fissuras, abscessos ou prolapso
- PELE: sem lesões, sem prurigo estrófulo
- GERAL: sem adenomegalias periféricas

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Método de Graham (fita gomada) — 3 amostras em dias alternados	**Positivo: ovos operculados de Enterobius vermicularis visualizados na 1ª amostra**	Negativo

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #211 · UBS — Atenção Primária · nível simples

Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais ao início. Entregar resultado do método de Graham somente se o candidato solicitar este exame especificamente. Orientar que a coleta é feita pela manhã, antes do banho e da higiene perianal, com fita adesiva transparente pressionada na região perianal.

PERFIL DO PACIENTE

T.A.S., 7 anos, masculino, 2ª série do ensino fundamental. Mora com a mãe, pai e irmã de 5 anos. Frequenta escola pública. Mãe relata que a irmã também está coçando.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal (mãe)	“Doutor, meu filho tá com uma coceira horrível aqui atrás, na região do bumbum, especialmente de noite. Já faz umas três semanas assim. Ele não tá conseguindo dormir direito.”
Sobre o prurido (mãe)	“É de noite, principalmente. De dia ele fica bem, mas quando vai dormir começa a coçar. Uma noite eu fui ver e tinha umas coisinhas brancas pequeninhas se mexendo ali perto do ânus dele.”
Sobre outros sintomas (mãe)	“Tá mais irritado, não tá querendo comer direito e tá com sono durante o dia. Mas febre não teve.”
Sobre irmã (mãe)	“A irmã de 5 anos também tá coçando bastante. Acho que ela também tem.”
Sobre a escola (mãe)	“Ele estuda em escola pública. A professora não avisou nada, mas ele tem vários amiguinhos.”
Sobre higiene (mãe)	“Eu ensino eles a lavar as mãos, mas é criança né, esquece. Ele roe bastante a unhinha também.”
Sobre tratamento anterior (mãe)	“Ainda não tratei, fui direto pro médico. Comprei um vermífugo genérico na farmácia mas ainda não dei porque queria perguntar pro senhor primeiro.”
Pergunta ativa (mãe)	“É lombriga, doutor? Precisa de exame de fezes?”
Pergunta ativa (mãe)	“Eu preciso tomar remédio também? E o marido e a outra filha?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Irmã de 5 anos com prurido perianal semelhante há 2 semanas — só revela se o candidato perguntar especificamente sobre sintomas em outros membros da família
- Pai e mãe também relatam prurido leve perianal à noite — só revela se perguntado sobre sintomas nos adultos da casa
- Hábito de roer unhas na criança — só revela se perguntado sobre hábitos da criança

COMPORTAMENTO DO ATOR

Mãe colaborativa, levemente constrangida, com tom de cansaço por noites mal dormidas. Demonstra preocupação com o filho. Receptiva às orientações. Fica mais tranquila quando o candidato explica que a doença é comum, benigna e de fácil tratamento. A criança fica irrequieta durante o exame.

GABARITO

Infectologia · Estação #211 · UBS — Atenção Primária · nível simples

Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas

Enterobíase (oxiuríase) em criança escolar, com transmissão domiciliar confirmada pela presença de sintomas em irmã (e possivelmente pais).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Candidíase perianal — prurido perianal com eritema; sem padrão noturno exclusivo; sem verminhas visíveis; mais comum em lactentes ou pacientes imunossuprimidos; tratamento com antifúngico tópico
- Dermatite de contato perianal — prurido sem padrão noturno, associado a sabonetes ou lenços umedecidos; sem ovos no método de Graham
- Outras helmintíases intestinais (Ascaris, Trichuris) — podem coexistir; geralmente sintomas mais sistêmicos; ovos diferentes no EPF; não causam prurido perianal noturno clássico
- Abuso sexual — deve ser considerado em qualquer criança com sintomas genitais ou perianais; afastado pela história clínica coerente e achado parasitológico positivo

CONTEXTO CLÍNICO

Criança escolar com prurido perianal de predomínio noturno há 3 semanas, com relato materno de verminhas visíveis, escoriações perianais ao exame e método de Graham positivo. Transmissão domiciliar evidenciada pela irmã sintomática. Quadro clínico clássico de oxiuríase por Enterobius vermicularis.

JUSTIFICATIVA

Enterobius vermicularis causa prurido perianal noturno intenso pois as fêmeas migram para a região perianal à noite para oviposição. O método de Graham (fita adesiva perianal coletada pela manhã antes do banho) é o exame de escolha — sensibilidade ~90% com 3 amostras. EPF é inadequado para diagnóstico pois os ovos raramente são encontrados nas fezes.

ANAMNESE ESPERADA

- Caracterizar o prurido: horário (noturno = clássico), intensidade, início, evolução
- Perguntar se a mãe/cuidador observou verminhas brancas na região perianal
- Investigar sintomas em outros membros da família (transmissão domiciliar é regra)
- Perguntar sobre frequência escolar e contatos com crianças
- Investigar hábitos de higiene: lavar mãos antes das refeições, roer unhas, coçar e levar à boca
- Investigar outros sintomas: irritabilidade, insônia, dor abdominal, anorexia
- Perguntar sobre tratamentos anteriores

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Avaliar estado geral da criança
- Examinar a região perianal: eritema, escoriações, presença visível de parasitas
- Exame abdominal: geralmente normal
- Pesquisar sinais de desnutrição
- Avaliar higiene das unhas

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Método de Graham (fita gomada/Scotch tape test)	Exame de escolha para enterobíase — ovos raramente aparecem em EPF; coleta perianal pela manhã antes do banho, por 3 dias alternados	Ovos operculados de E. vermicularis — confirma diagnóstico
EPF (exame parasitológico de fezes) — opcional	Baixa sensibilidade para E. vermicularis; indicado se suspeita de co-infestação com outros helmintos	Geralmente negativo para E. vermicularis

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: Albendazol 400mg VO dose única (crianças > 2 anos e adultos) OU Mebendazol 100mg VO dose única — REPETIR após 2 semanas (destrói os adultos mas não os ovos; 2ª dose elimina os que eclodiram); TRATAR TODOS OS CONTATOS DOMICILIARES SIMULTANEAMENTE (mãe, pai, irmã) independentemente de sintomas — regra fundamental
- Não farmacológica: Higiene das mãos com frequência, especialmente antes das refeições e após o banho; cortar as unhas rentes; trocar e lavar a roupa de cama, pijamas e roupas íntimas com água quente (>60°C) no dia do tratamento; não sacudir roupas de cama (dispersa ovos)
- Orientações: Explicar o ciclo do parasita (transmissão fecal-oral, autoinfestação); reforçar que a doença é muito comum em escolares e não significa descuido; orientar escola se necessário
- Seguimento: Retorno em 4 semanas; repetir tratamento se persistência de sintomas

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Apresentar-se pelo nome
- Explicar o diagnóstico de forma acessível ("são uns verminhos muito comuns em crianças da escola") sem causar constrangimento
- Orientar claramente sobre a necessidade de tratar TODOS os membros da família ao mesmo tempo
- Ensinar a técnica do método de Graham para próximas pesquisas
- Perguntar se tem dúvidas

ERROS CRÍTICOS

- Solicitar apenas EPF sem método de Graham — baixíssima sensibilidade para E. vermicularis; erro diagnóstico
- Tratar apenas a criança sem tratar todos os contatos domiciliares — garante reinfestação e falha terapêutica
- Não orientar a segunda dose após 2 semanas — dose única não elimina os ovos, recidiva certa
- Diagnosticar "lombriga" (Ascaris) e prescrever tratamento inadequado sem solicitar exame confirmatório
- Não orientar medidas de higiene (lavagem de roupas, corte de unhas) — ciclo de transmissão não é interrompido

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #211 · UBS — Atenção Primária · nível simples

Criança com coceira no ânus à noite há 3 semanas

CHECKLIST — CRIANÇA COM COCEIRA PERIANAL À NOITE (OXIURÍASE)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Apresentou-se ao paciente e à mãe CFM Res. 2.232/2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou o diagnóstico sem causar constrangimento, usando linguagem acessível PNAB/MS 2017	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Caracterizou o prurido perianal de predomínio noturno Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre visualização de verminhas brancas na região perianal Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou sintomas em todos os membros da família Protocolo MS Helmintíases, 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Questionou hábitos de higiene (lavar mãos, roer unhas) Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,3	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Realizou exame da região perianal e identificou escoriações/eritema Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou estado geral e nutricional da criança Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,3	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou método de Graham (fita gomada) como exame de escolha Protocolo MS Helmintíases, 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Não solicitou apenas EPF como único exame diagnóstico Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO	Pts	Avaliação
Prescreveu Albendazol 400mg ou Mebendazol 100mg dose única Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou repetição do tratamento após 2 semanas Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Prescreveu tratamento para TODOS os contatos domiciliares simultaneamente Protocolo MS Helmintíases, 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou medidas de higiene (roupas de cama, unhas, lavagem de mãos) Protocolo MS Helmintíases, 2022	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou se havia dúvidas ao final CFM Res. 2.232/2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **8,6** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #280 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos

CENÁRIO

Atendimento no Pronto-Socorro em período de epidemia de dengue na cidade.

PACIENTE

Bruno Henrique Souza, 24 anos, sexo masculino, estudante universitário.

QUEIXA PRINCIPAL

Febre alta há 4 dias, hoje com melhora da febre mas piora do estado geral, dor abdominal e vômitos.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, com atenção ao dia de doença e sinais de alarme.
2. Realize o exame físico geral dirigido, incluindo prova do laço se pertinente.
3. Classifique o caso conforme os grupos de risco do Ministério da Saúde.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha a conduta terapêutica e defina necessidade de internação/observação.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #280 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
100/70 mmHg	112 bpm	22 irpm	37,2 °C (afebril no momento, febre até ontem)	78 kg	1,78 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, letárgico, pele fria em extremidades, tempo de enchimento capilar de 3 segundos.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: doloroso à palpação difusa, mais intenso em hipocôndrio direito (dor abdominal intensa e contínua), sem sinais de irritação peritoneal francos.
- PELE: exantema maculopapular discreto em tronco; prova do laço positiva (>20 petéquias em área de 2,5 cm²).
- CARDIOVASCULAR: taquicárdico, pulsos finos.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hematócrito	**52% (basal conhecido do paciente: 42%)**	Elevação >20% do basal sugere hemoconcentração/extravasamento plasmático
Plaquetas	**68.000/mm³**	150.000 – 450.000/mm³
Leucócitos	**2.900/mm³**	4.000 – 11.000/mm³
Teste rápido NS1 (dengue)	**Positivo**	Negativo
TGO/TGP	**TGO 98 U/L, TGP 82 U/L**	< 35 U/L

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #280 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos

NOTA AO AVALIADOR

O hematócrito e as plaquetas são os exames mais críticos deste caso — entregar assim que solicitados, reforçando a importância da hemoconcentração (>20% do basal) como sinal de extravasamento plasmático. O NS1 já havia sido coletado antes desta consulta pela triagem.

PERFIL DO PACIENTE

Estudante universitário, mora em república com colegas, relata que dois colegas também tiveram "dengue" recentemente. Não tem comorbidades. Vem se hidratando por conta própria com água, mas com dificuldade pelos vômitos.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), estou com febre há uns 4 dias, ontem a febre baixou mas eu piorei, comecei a vomitar bastante e sinto uma dor forte na barriga.”
Sobre a febre	“A febre era bem alta, uns 39-40°C, com dor no corpo todo e atrás dos olhos. Ontem ela sumiu, mas eu me sinto pior ainda.”
Sobre a dor abdominal	“É uma dor forte, contínua, do lado direito da barriga, bem diferente de cólica.”
Sobre vômitos	“Vomitei umas 5 vezes hoje, não consigo segurar nem água direito.”
Sobre sangramentos	“Não notei sangramento de nariz ou gengiva, mas minha pele ficou com umas manchinhas vermelhas em alguns lugares.”
Sobre contatos/epidemiologia	“Dois amigos meus que moram comigo tiveram dengue há umas 2 semanas, e tem bastante gente doente na cidade também.”
Pergunta ativa — gravidade	“Doutor(a), isso é grave? Por que eu estou piorando se a febre já passou?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Notou sonolência importante e um certo desânimo incomum nas últimas horas, além de referir "sensação estranha de fraqueza extrema" — só revela se perguntado ativamente sobre letargia/estado mental
- Tem tomado ibuprofeno por conta própria para a febre e dores no corpo — informação relevante que só revela se perguntado sobre automedicação (AINEs são contraindicados na suspeita de dengue)
- Notou que está urinando bem menos que o habitual nas últimas horas — só revela se perguntado sobre débito urinário
- Está com muito medo pois um vizinho teve "dengue grave" recentemente e precisou de UTI — verbaliza esse medo se o candidato acolher a situação

COMPORTAMENTO DO ATOR

Demonstrar letargia e fraqueza importante (fala mais devagar, parece sonolento). Fácies de dor ao exame abdominal. Ansioso ao lembrar do vizinho com dengue grave.

GABARITO

Infectologia · Estação #280 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos

Dengue com sinais de alarme (Grupo C conforme classificação de risco do Ministério da Saúde): dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, hemoconcentração, plaquetopenia e letargia — período crítico da doença (defervescência).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Dengue sem sinais de alarme (Grupo B/A) — entra pelo quadro febril inicial; sai pela presença clara de sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hemoconcentração), que reclassificam o caso para grupo de maior risco.
- Chikungunya — entra como diferencial de síndrome febril aguda em área endêmica; sai pela predominância de artralgia intensa e incapacitante na chikungunya, não sendo o quadro predominante aqui, e pela positividade do NS1 para dengue.
- Abdome agudo cirúrgico (ex.: apendicite, colecistite) — entra pela dor abdominal intensa; sai pelo contexto epidemiológico, sorologia positiva para dengue e pela associação com hemoconcentração/plaquetopenia, não esperadas em abdome agudo cirúrgico isolado.
- Leptospirose — entra como diferencial de síndrome febril com alteração hepática; sai pela ausência de sufusão conjuntival e de outros achados típicos, e pela confirmação laboratorial de dengue (NS1 positivo).

CONTEXTO CLÍNICO

A dengue é a arbovirose mais prevalente no Brasil, causada por vírus transmitido pelo Aedes aegypti. A fase crítica da doença ocorre tipicamente entre o 3º e o 7º dia, coincidindo com a defervescência (queda da febre), período em que pode ocorrer extravasamento plasmático e os sinais de alarme devem ser ativamente pesquisados, pois definem a necessidade de internação e hidratação venosa mais agressiva conforme a classificação de risco do Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de dengue com sinais de alarme é sustentado pela positividade do NS1 associada à presença de dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, letargia, hemoconcentração (elevação do hematócrito >20% do basal) e plaquetopenia, achados que classificam o paciente no Grupo C de risco do Ministério da Saúde, exigindo internação para reposição volêmica supervisionada.

ANAMNESE ESPERADA

- Dia de início e evolução da febre
- Sintomas associados (cefaleia retro-orbitária, mialgia, exantema)
- Pesquisa ativa e sistemática de sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, letargia, hipotensão, diminuição da diurese)
- Uso de medicações (especialmente AINEs, contraindicados)
- Contexto epidemiológico (casos na comunidade, viagens)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Aferição cuidadosa de sinais vitais, incluindo pressão arterial e avaliação de perfusão periférica
- Prova do laço
- Palpação abdominal buscando dor à palpação de hipocôndrio direito (hepatomegalia dolorosa)
- Pesquisa de sinais de sangramento cutâneo-mucoso
- Avaliação do nível de consciência

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Hemograma completo (hematócrito seriado e plaquetas)	Essencial para identificar hemoconcentração (extravasamento plasmático) e plaquetopenia, definindo classificação de risco	Hemoconcentração e plaquetopenia, compatíveis com sinais de alarme
Teste rápido NS1 ou sorologia IgM (conforme dia de doença)	Confirmação laboratorial da infecção pelo vírus da dengue	Positivo
Transaminases (TGO/TGP)	Avaliar acometimento hepático associado	Frequentemente elevadas

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: hidratação venosa vigorosa com cristaloides, conforme protocolo de reposição volêmica para dengue com sinais de alarme (Grupo C); antitérmico com paracetamol (NUNCA AINEs ou ácido acetilsalicílico, pelo risco de sangramento); suspender imediatamente qualquer AINE em uso
- Não farmacológica: internação hospitalar obrigatória para observação e reavaliação seriada de hematócrito, plaquetas e sinais vitais
- Orientações ao paciente: explicar que a piora após a queda da febre é esperada e faz parte da fase crítica da doença, justamente por isso exige internação e vigilância rigorosa; orientar sobre sinais de piora adicional (sangramentos, hipotensão, dificuldade respiratória) que exigiriam reclassificação para dengue grave (Grupo D)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma clara por que a melhora da febre não significa melhora do quadro, e sim entrada na fase crítica
- Acolher o medo do paciente relacionado a casos graves conhecidos
- Reforçar a importância da internação e do acompanhamento seriado
- Orientar suspensão imediata de AINEs em uso

ERROS CRÍTICOS

- Não reconhecer os sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos persistentes, letargia, hemoconcentração) e liberar o paciente para casa
- Não solicitar hematócrito e plaquetas diante de suspeita de dengue na fase crítica
- Prescrever ou não suspender anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) ou ácido acetilsalicílico
- Não iniciar hidratação venosa vigorosa diante de sinais de alarme confirmados
- Não indicar internação hospitalar para observação diante de dengue com sinais de alarme (Grupo C)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #280 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre alta há 4 dias com dor abdominal e vômitos

CHECKLIST — FEBRE ALTA COM DOR ABDOMINAL E VÔMITOS (DENGUE COM SINAIS DE ALARME)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Apresentou-se pelo nome ao paciente CFM Res. 2.217/2018	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Explicou por que a melhora da febre não significa melhora do quadro Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou dia de início e evolução da febre Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou ativamente sinais de alarme (dor abdominal, vômitos persistentes, sangramentos) Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre uso de AINEs/AAS Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Aferiu sinais vitais com atenção à perfusão periférica Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Realizou a prova do laço Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou o nível de consciência (letargia) Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou hemograma com hematócrito e plaquetas Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	1	☐ A ☐ P ☐ I
Classificou corretamente como Grupo C (sinais de alarme) Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Indicou internação para hidratação venosa vigorosa Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Suspendeu/orientou não usar AINEs ou AAS Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou sinais de piora para dengue grave (Grupo D) Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Dengue	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #281 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Ferida genital indolor há 2 semanas

CENÁRIO

Consulta de demanda espontânea na UBS, período da tarde.

PACIENTE

Rodrigo Almeida Barros, 27 anos, sexo masculino, vendedor.

QUEIXA PRINCIPAL

Ferida genital indolor há cerca de 2 semanas, que não melhora.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida ao caso, incluindo história sexual detalhada.
2. Realize o exame físico genital e geral dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e os diferenciais.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha o tratamento conforme estadiamento e oriente sobre parceiros.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #281 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Ferida genital indolor há 2 semanas

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
118/76 mmHg	74 bpm	16 irpm	36,4 °C	76 kg	1,75 m

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, corado, hidratado, sem sinais de toxemia.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- GENITÁLIA: úlcera única, de bordas bem definidas, base endurecida, indolor à palpação, localizada na glande, sem secreção purulenta.
- LINFONODOS: linfadenopatia inguinal bilateral, indolor, móvel, sem sinais flogísticos (bubão sifilítico).
- PELE: sem exantema no momento do exame.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Teste rápido treponêmico	**Reagente**	Não reagente
VDRL (teste não treponêmico)	**Reagente, titulação 1:32**	Não reagente
Teste rápido HIV	Não reagente	Não reagente
HBsAg e Anti-HCV	Não reagentes	Não reagentes

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #281 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Ferida genital indolor há 2 semanas

NOTA AO AVALIADOR

Os testes sorológicos devem ser entregues conforme solicitados. Reforçar que a testagem para outras ISTs (HIV, hepatites B e C) deve ser oferecida de rotina diante do diagnóstico de uma IST, mesmo que o candidato não pense nisso espontaneamente de início.

PERFIL DO PACIENTE

Vendedor, solteiro, relata múltiplos parceiros sexuais nos últimos meses, uso inconsistente de preservativo. Notou a lesão genital há 2 semanas e não procurou atendimento antes por acreditar que "iria passar sozinha", já que não dói.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), apareceu uma ferida no meu pênis há umas 2 semanas, não dói nada, mas não está sarando.”
Sobre a ferida	“É só uma, bem redondinha, as bordas parecem "duras" quando eu toco, mas realmente não sinto dor nenhuma.”
Sobre vida sexual	“Tenho tido vários parceiros sexuais nos últimos meses, às vezes uso camisinha, às vezes não, dependendo da situação.”
Sobre sintomas sistêmicos	“Não tenho febre nem mal-estar, só essa ferida mesmo e umas "ínguas" na virilha que notei.”
Sobre exames prévios de IST	“Nunca fiz teste para nenhuma doença sexualmente transmissível antes, confesso que tinha vergonha de procurar.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“Doutor(a), o que é isso? É grave? Tem cura?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Teve uma lesão genital semelhante há cerca de 2 anos que sumiu sozinha sem tratamento, e nunca associou a uma IST — só revela se perguntado sobre episódios anteriores de lesões genitais
- Tem parceiros tanto do sexo masculino quanto feminino, mas tem receio de comentar isso espontaneamente — só revela se o ambiente for acolhedor e não julgador, e se perguntado de forma aberta sobre parcerias sexuais
- Está com vergonha de ter que "avisar" os parceiros recentes sobre o diagnóstico — só revela essa preocupação se o candidato abordar o tratamento de parceiros
- Não sabe se sífilis tem cura ou se é "como o HIV" — verbaliza essa dúvida ao ser informado do diagnóstico

COMPORTAMENTO DO ATOR

Levemente constrangido ao falar sobre vida sexual, mas se abre mais conforme percebe ambiente não julgador. Preocupado ao ouvir o nome "sífilis", associando a doença grave incurável. Colaborativo durante o exame físico.

GABARITO

Infectologia · Estação #281 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Ferida genital indolor há 2 semanas

Sífilis adquirida, estágio primário (cancro duro), com sorologia confirmatória positiva (teste treponêmico reagente e VDRL reagente com titulação 1:32).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Herpes genital — entra como causa comum de úlcera genital; sai pela característica da lesão (única, indolor, de base endurecida), diferente das múltiplas vesículas/úlceras dolorosas e agrupadas típicas do herpes.
- Cancro mole (cancroide) — entra como diferencial de úlcera genital; sai pela ausência de dor importante e de múltiplas lesões com bordas irregulares e fundo purulento, características do cancro mole, além da confirmação sorológica de sífilis.
- Linfogranuloma venéreo — entra pela linfadenopatia inguinal associada; sai pela ausência de supuração/fistulização ganglionar característica e pela úlcera genital típica de sífilis primária associada à sorologia positiva.
- Donovanose — entra como diferencial de úlcera genital crônica; sai pela evolução mais aguda (2 semanas) e pela confirmação sorológica de sífilis, tornando este o diagnóstico mais provável e explicativo do quadro.

CONTEXTO CLÍNICO

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum, com incidência crescente no Brasil nos últimos anos, sendo doença de notificação compulsória. A fase primária caracteriza-se pelo cancro duro — úlcera única, indolor, de base endurecida — que surge no local de inoculação, geralmente acompanhada de linfadenopatia regional não dolorosa, podendo resolver espontaneamente mesmo sem tratamento, o que não significa cura da infecção.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de sífilis primária é sustentado pela apresentação clínica característica do cancro duro (úlcera única, indolor, base endurecida, com linfadenopatia inguinal não dolorosa associada), confirmado laboratorialmente pela positividade de teste treponêmico e não treponêmico (VDRL reagente, titulação 1:32), conforme o fluxograma diagnóstico do Ministério da Saúde para sífilis.

ANAMNESE ESPERADA

- Caracterização da lesão genital (tempo de evolução, dor, número de lesões)
- História sexual detalhada, sem julgamento (número e gênero de parceiros, uso de preservativo)
- Episódios semelhantes anteriores
- Sintomas sistêmicos associados
- Conhecimento sobre testagem prévia para ISTs

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Inspeção cuidadosa da genitália, identificando características da úlcera (número, bordas, base, dor)
- Palpação de linfonodos inguinais
- Exame de pele buscando exantema (embora mais característico da fase secundária)
- Exame geral

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Teste rápido treponêmico e/ou VDRL (teste não treponêmico)	Confirmação diagnóstica e, no caso do VDRL, acompanhamento de resposta terapêutica pela titulação	Ambos reagentes, com titulação do VDRL orientando seguimento
Testagem para HIV, hepatites B e C	Rastreio obrigatório de outras ISTs em todo paciente diagnosticado com uma IST	Idealmente não reagentes; orienta conduta adicional conforme resultado

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, dose única intramuscular, para sífilis primária (esquema conforme estadiamento — sífilis recente); em caso de alergia confirmada à penicilina, considerar dessensibilização (especialmente se parceria sexual gestante) ou esquemas alternativos conforme protocolo
- Não farmacológica: notificação compulsória do caso; convocação e tratamento de parceiros sexuais dos últimos 90 dias (ou do período assintomático relevante)
- Orientações ao paciente: explicar que a sífilis tem cura com o tratamento adequado, mas que a resolução espontânea da lesão NÃO significa cura da infecção; orientar sobre a necessidade de tratar os parceiros sexuais recentes; reforçar uso de preservativo e oferecer testagem periódica para ISTs; agendar seguimento com VDRL de controle (queda da titulação confirma resposta terapêutica)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Conduzir a história sexual sem julgamento, criando ambiente de confiança
- Esclarecer que a sífilis tem cura e desconstruir associações equivocadas com doenças incuráveis
- Abordar a necessidade de tratamento de parceiros de forma acolhedora, sem gerar culpa excessiva
- Verificar compreensão do diagnóstico e do plano terapêutico

ERROS CRÍTICOS

- Não confirmar o diagnóstico com testes sorológicos (treponêmico e não treponêmico) antes de tratar
- Não oferecer testagem para outras ISTs (HIV, hepatites B e C) diante do diagnóstico de sífilis
- Não notificar compulsoriamente o caso
- Não orientar sobre convocação e tratamento de parceiros sexuais
- Prescrever esquema terapêutico inadequado ao estadiamento (ex.: dose única quando indicado esquema estendido para sífilis tardia/duração ignorada)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #281 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Ferida genital indolor há 2 semanas

CHECKLIST — FERIDA GENITAL INDOLOR (SÍFILIS ADQUIRIDA)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Conduziu a história sexual sem julgamento Ministério da Saúde — PCDT IST	1	☐ A ☐ P ☐ I
Esclareceu que a sífilis tem cura, desconstruindo associação com doença incurável Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Caracterizou a lesão genital (dor, número, tempo de evolução) Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou história sexual detalhada (parceiros, uso de preservativo) Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre episódios semelhantes anteriores Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Examinou a genitália caracterizando bordas e base da úlcera Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Palpou linfonodos inguinais Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou teste treponêmico e VDRL antes de tratar Ministério da Saúde — PCDT IST	1	☐ A ☐ P ☐ I
Ofereceu testagem para HIV, hepatites B e C Ministério da Saúde — PCDT IST	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Prescreveu penicilina G benzatina no esquema correto para sífilis recente Ministério da Saúde — PCDT IST	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Notificou compulsoriamente o caso Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou convocação e tratamento de parceiros sexuais Ministério da Saúde — PCDT IST	1	☐ A ☐ P ☐ I
Agendou VDRL de seguimento Ministério da Saúde — PCDT IST	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **9,5** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #282 · UBS — Atenção Primária · nível difícil

Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente

CENÁRIO

Consulta de retorno na UBS para entrega de resultado de teste rápido realizado por demanda espontânea.

PACIENTE

Fábio Cardoso Nunes, 31 anos, sexo masculino, designer gráfico.

QUEIXA PRINCIPAL

Retorna assintomático para receber resultado de teste rápido de HIV realizado na semana anterior.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, incluindo história de exposição e sintomas.
2. Comunique o resultado do exame de forma apropriada.
3. Confirme o diagnóstico com o fluxograma laboratorial adequado.
4. Formule a conduta inicial, incluindo início de tratamento.
5. Oriente o paciente sobre seguimento, parceiros e prevenção combinada.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #282 · UBS — Atenção Primária · nível difícil

Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
116/74 mmHg	78 bpm	16 irpm	36,4 °C	70 kg	1,73 m

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, corado, hidratado, sem sinais de doença oportunista ou emagrecimento.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- PELE E MUCOSAS: sem lesões sugestivas de sarcoma de Kaposi ou candidíase oral.
- LINFONODOS: linfadenopatia cervical bilateral discreta, indolor, sem outras alterações relevantes ao exame geral.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Teste rápido de HIV (1ª amostra, realizado na semana anterior)	**Reagente**	Não reagente
Teste rápido de HIV (2º teste, confirmatório com metodologia diferente, realizado nesta consulta)	**Reagente**	Não reagente
Contagem de linfócitos CD4+	520 células/mm³	≥ 500 células/mm³
Carga viral do HIV	**18.400 cópias/mL**	Indetectável (paciente sem tratamento prévio)

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #282 · UBS — Atenção Primária · nível difícil

Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente

NOTA AO AVALIADOR

O fluxograma do Ministério da Saúde exige dois testes rápidos com metodologias diferentes (ou um rápido + um laboratorial) para confirmação diagnóstica antes de comunicar o diagnóstico definitivo — reforçar essa etapa caso o candidato queira comunicar o diagnóstico apenas com o primeiro teste.

PERFIL DO PACIENTE

Designer gráfico, tem parceiro fixo há 8 meses, relata relação sexual desprotegida com parceiro eventual há cerca de 2 meses. Procurou testagem por conta própria após essa exposição, sem sintomas até o momento.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser informado do resultado	“(muito abalado) Doutor(a)... isso quer dizer que eu tenho HIV? Eu vou morrer?”
Sobre exposição de risco	“Tive uma relação sem camisinha com um parceiro eventual há uns 2 meses, foi por isso que resolvi fazer o teste.”
Sobre sintomas	“Não sinto nada de diferente, nenhum sintoma, é por isso que fiquei tão surpreso com o resultado.”
Sobre parceiro fixo	“Tenho um namorado há 8 meses, moramos juntos... e agora eu não sei como vou contar isso para ele.”
Sobre conhecimento prévio sobre HIV	“Eu sei que hoje em dia existe tratamento, mas confesso que ainda tenho muito medo, lembro de coisas antigas que ouvi sobre a doença.”
Pergunta ativa — tratamento	“Doutor(a), existe tratamento? Eu vou precisar tomar remédio para sempre? Posso ter uma vida normal?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Está em pânico com a possibilidade de ter transmitido o HIV para o parceiro fixo, mas não verbaliza espontaneamente — só revela essa preocupação se o candidato abordar ativamente a testagem e notificação de parceiros
- Nunca fez PrEP (profilaxia pré-exposição) por desconhecimento de que existia essa opção — só revela se perguntado sobre conhecimento prévio de estratégias de prevenção
- Tem um histórico de ansiedade e já fez acompanhamento psicológico no passado — só revela se perguntado sobre saúde mental ou se o candidato oferecer suporte psicológico
- Está preocupado com sigilo médico e com a possibilidade de o diagnóstico "vazar" no trabalho — verbaliza essa preocupação se o candidato tocar no tema de confidencialidade

COMPORTAMENTO DO ATOR

Visivelmente abalado e assustado ao receber a notícia, pode chorar ou ficar em silêncio por um momento. Antigas concepções sobre a gravidade da doença ("é uma sentença de morte") vêm à tona se não esclarecidas. Gradualmente mais tranquilo conforme recebe informações atualizadas e acolhimento.

GABARITO

Infectologia · Estação #282 · UBS — Atenção Primária · nível difícil

Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente

Infecção pelo HIV confirmada (dois testes rápidos reagentes com metodologias diferentes), assintomática, com contagem de CD4+ preservada (520 células/mm³) e carga viral detectável.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Não se aplica diagnóstico diferencial clássico de doença — o diagnóstico já está laboratorialmente confirmado pelo fluxograma adequado (dois testes reagentes); a tarefa central do candidato é a correta confirmação diagnóstica, comunicação da notícia e início oportuno do tratamento antirretroviral.

CONTEXTO CLÍNICO

O diagnóstico da infecção pelo HIV no Brasil segue fluxograma estabelecido pelo Ministério da Saúde, exigindo confirmação com dois testes de metodologias diferentes antes da comunicação definitiva ao paciente. A recomendação atual (estratégia "testar e tratar") é o início imediato da terapia antirretroviral (TARV) após o diagnóstico confirmado, independentemente da contagem de CD4+, dado o benefício em reduzir morbimortalidade e transmissão (tratamento como prevenção).

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico é confirmado pela positividade de dois testes rápidos com metodologias diferentes, conforme fluxograma do Ministério da Saúde, corroborado pela carga viral detectável. A contagem de CD4+ ainda preservada (520 células/mm³) indica fase assintomática da infecção, mas não contraindica nem posterga o início do tratamento, que deve ser oferecido imediatamente conforme a estratégia atual "testar e tratar".

ANAMNESE ESPERADA

- História de exposição de risco (relações sexuais desprotegidas, parcerias)
- Sintomas sugestivos de infecção aguda ou doenças oportunistas
- Situação de parcerias sexuais atuais e necessidade de testagem/notificação
- Conhecimento prévio sobre HIV e estratégias de prevenção (PrEP, PEP)
- Rede de apoio emocional e histórico de saúde mental

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Exame geral buscando sinais de doenças oportunistas ou manifestações da infecção pelo HIV (lesões cutâneo-mucosas, linfadenopatia, emagrecimento)
- Aferição de peso e sinais vitais

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Segundo teste rápido de HIV com metodologia diferente (ou teste laboratorial confirmatório)	Etapa obrigatória do fluxograma diagnóstico antes da confirmação definitiva	Reagente, confirmando o diagnóstico
Contagem de linfócitos CD4+	Avaliar o estado imunológico e orientar rastreio de infecções oportunistas	Definir estadiamento imunológico
Carga viral do HIV	Estabelecer basal antes do início do tratamento e monitorar resposta terapêutica futura	Detectável antes do tratamento; objetivo é indetectabilidade após TARV

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Rastreio de outras ISTs (sífilis, hepatites B e C) e genotipagem pré-tratamento quando disponível	Coinfecções são comuns e devem ser rastreadas; genotipagem orienta escolha do esquema TARV em cenários de transmissão de resistência	Conforme disponibilidade e protocolo local

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: iniciar terapia antirretroviral (TARV) imediatamente após confirmação diagnóstica, independentemente da contagem de CD4+, conforme estratégia "testar e tratar" do Ministério da Saúde (esquema preferencial atual combina inibidores da transcriptase reversa análogos e inibidor de integrase)
- Não farmacológica: encaminhamento para serviço especializado em HIV/aids, se necessário, mantendo vínculo com a atenção primária; oferecer suporte psicológico
- Orientações ao paciente: explicar que o HIV hoje é uma condição crônica tratável, com expectativa de vida próxima à da população geral quando em tratamento adequado; explicar o conceito de "indetectável = intransmissível" (I=I) como forma de reduzir estigma e ansiedade sobre transmissão ao parceiro; orientar testagem e aconselhamento do parceiro fixo; reforçar sigilo e confidencialidade das informações de saúde

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar o diagnóstico em ambiente privado, com tempo adequado e sem pressa
- Acolher a reação emocional do paciente, validando o impacto psicológico do diagnóstico
- Desconstruir concepções ultrapassadas sobre a gravidade/mortalidade da doença com informação atualizada
- Abordar de forma sensível a necessidade de testagem do parceiro fixo
- Reforçar a confidencialidade das informações de saúde

ERROS CRÍTICOS

- Comunicar o diagnóstico definitivo com base em apenas um teste rápido, sem confirmação pelo fluxograma completo
- Postergar o início da TARV aguardando contagem de CD4+ baixa, contrariando a estratégia atual de "testar e tratar"
- Comunicar a notícia de forma alarmista ou desatualizada, reforçando estigma
- Não abordar a necessidade de testagem do parceiro fixo
- Não oferecer encaminhamento para suporte psicológico diante do impacto emocional evidente

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #282 · UBS — Atenção Primária · nível difícil

Retorno para resultado de teste rápido de HIV reagente

CHECKLIST — RETORNO PARA RESULTADO DE TESTE RÁPIDO DE HIV REAGENTE

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS	Pts	Avaliação
Comunicou o diagnóstico em ambiente privado, com tempo adequado CFM Res. 2.217/2018	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Desconstruiu concepções ultrapassadas sobre gravidade/mortalidade da doença Ministério da Saúde — PCDT HIV	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou história de exposição de risco e parcerias sexuais atuais Ministério da Saúde — PCDT HIV	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre sintomas sugestivos de doenças oportunistas Ministério da Saúde — PCDT HIV	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Realizou exame geral buscando sinais de doenças oportunistas Ministério da Saúde — PCDT HIV	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Confirmou o diagnóstico com um 2º teste de metodologia diferente antes de comunicar definitivamente Ministério da Saúde — PCDT HIV	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou CD4+, carga viral e rastreio de coinfecções (sífilis, hepatites) Ministério da Saúde — PCDT HIV	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Iniciou TARV imediatamente, independente da contagem de CD4+ ("testar e tratar") Ministério da Saúde — PCDT HIV	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Explicou o conceito "Indetectável = Intransmissível" (I=I) Ministério da Saúde — PCDT HIV	1	☐ A ☐ P ☐ I
Abordou a testagem do parceiro fixo e ofereceu suporte psicológico Ministério da Saúde — PCDT HIV	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **9,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #283 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente

CENÁRIO

Atendimento no Pronto-Socorro, período de chuvas intensas com alagamentos na região.

PACIENTE

Wagner Souza Lima, 40 anos, sexo masculino, gari (garí/coletor de lixo urbano).

QUEIXA PRINCIPAL

Febre alta, dor muscular intensa nas panturrilhas e olhos avermelhados há 3 dias, após período trabalhando em área alagada.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, com atenção à exposição epidemiológica.
2. Realize o exame físico geral dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e os diferenciais.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha a conduta terapêutica e avalie critérios de gravidade/internação.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #283 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
108/68 mmHg	104 bpm	20 irpm	39,1 °C	80 kg	1,76 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, febril, ictérico (icterícia rubínica — tom alaranjado característico), desidratação leve a moderada.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- OLHOS: sufusão conjuntival bilateral (hiperemia conjuntival sem secreção).
- MÚSCULOS: dor intensa à palpação de panturrilhas (mialgia importante).
- ABDOME: discreto desconforto difuso, sem sinais de irritação peritoneal; leve hepatomegalia palpável.
- PELE: icterícia de tonalidade alaranjada característica.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Bilirrubina total e frações	**BT 6,8 mg/dL (predomínio de direta)**	< 1,2 mg/dL
Creatinina sérica	**2,1 mg/dL**	0,7 – 1,3 mg/dL
CPK (creatinofosfoquinase)	**890 U/L**	< 190 U/L
Plaquetas	**92.000/mm³**	150.000 – 450.000/mm³
Sorologia IgM para leptospira (ou teste rápido)	**Reagente**	Não reagente

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #283 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente

NOTA AO AVALIADOR

A sorologia pode levar alguns dias para ficar pronta em muitos serviços — o diagnóstico inicial e o início do tratamento devem ser baseados no quadro clínico-epidemiológico típico, sem aguardar confirmação sorológica, dada a gravidade potencial da doença.

PERFIL DO PACIENTE

Gari, trabalha na coleta de lixo urbano, teve contato direto com água de enchente contaminada por vários dias na semana anterior ao início dos sintomas devido às fortes chuvas na cidade. Não usa equipamento de proteção adequado no trabalho (botas, luvas).

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), estou com febre alta, uma dor terrível nas panturrilhas, e meus olhos ficaram bem vermelhos, sem remela nem nada.”
Sobre exposição	“Trabalho na coleta de lixo, e essa semana tivemos que trabalhar em rua alagada por causa da chuva forte, fiquei com a perna na água suja várias vezes.”
Sobre a dor muscular	“A dor é bem forte, principalmente na panturrilha, quase não consigo andar direito.”
Sobre icterícia	“(surpreso) Fiquei amarelado? Não tinha notado isso, só sentia mal-estar geral mesmo.”
Sobre sintomas urinários	“Notei que estou urinando bem menos que o normal nos últimos dias.”
Sobre uso de proteção no trabalho	“A gente não usa muito equipamento de proteção, bota às vezes, mas nessa correria da enchente nem sempre dá tempo.”
Pergunta ativa — gravidade	“Doutor(a), isso é grave? Peguei alguma coisa da água suja?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Notou sangramento gengival leve ao escovar os dentes nos últimos dias, sinal de gravidade que não relata espontaneamente — só revela se perguntado ativamente sobre sangramentos
- Tem tido falta de ar leve ao esforço nas últimas horas, possível sinal de comprometimento pulmonar (forma grave/Síndrome de Weil com hemorragia pulmonar) — só revela se perguntado sobre sintomas respiratórios
- Vários colegas de trabalho também apresentaram sintomas semelhantes na mesma semana — só revela se perguntado sobre outros casos entre colegas
- Está preocupado em perder dias de trabalho, pois é o único provedor da casa — só revela essa preocupação se o candidato abordar necessidade de afastamento/internação

COMPORTAMENTO DO ATOR

Demonstrar dor importante ao exame de panturrilhas (queixar-se, retirar a perna). Surpreso ao saber que está ictérico. Preocupação crescente conforme a gravidade do quadro é discutida.

GABARITO

Infectologia · Estação #283 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente

Leptospirose, forma íctero-hemorrágica (síndrome de Weil), com comprometimento renal, hepático e sinais de gravidade (plaquetopenia, indícios de sangramento e possível comprometimento pulmonar).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Hepatite viral aguda — entra pela icterícia; sai pela presença de mialgia intensa em panturrilhas, sufusão conjuntival e comprometimento renal associado, achados não típicos de hepatite viral isolada, além do contexto epidemiológico de exposição a água de enchente.
- Dengue — entra como diferencial de síndrome febril aguda; sai pela presença de icterícia rubínica, sufusão conjuntival e comprometimento renal significativo, mais característicos de leptospirose grave, associados ao contexto epidemiológico de exposição a enchente.
- Hantavirose — entra como diferencial de síndrome febril com comprometimento pulmonar; sai pelo contexto epidemiológico mais compatível com exposição a água contaminada (leptospirose) do que a roedores silvestres/áreas rurais fechadas, embora ambas devam ser consideradas em quadros febris graves pós-exposição ambiental.
- Malária — entra como causa de febre e icterícia; sai pela ausência de história de viagem a área endêmica de malária e pelo contexto epidemiológico claro de exposição a enchente, mais compatível com leptospirose.

CONTEXTO CLÍNICO

A leptospirose é uma zoonose bacteriana causada por espécies de Leptospira, transmitida pelo contato com água ou solo contaminados pela urina de roedores infectados, sendo particularmente prevalente em períodos de enchentes em áreas urbanas com saneamento precário. A forma grave (síndrome de Weil) cursa com a tríade de icterícia, insuficiência renal aguda e diátese hemorrágica, podendo evoluir para hemorragia pulmonar maciça, principal causa de óbito na doença.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de leptospirose forma grave (síndrome de Weil) é sustentado pelo quadro clínico-epidemiológico característico (exposição a água de enchente, febre, mialgia intensa em panturrilhas, sufusão conjuntival), associado a icterícia rubínica, insuficiência renal aguda (creatinina elevada), plaquetopenia e elevação de CPK, corroborado pela sorologia IgM reagente, configurando quadro grave que exige internação e vigilância rigorosa de complicações hemorrágicas e pulmonares.

ANAMNESE ESPERADA

- Caracterização da exposição epidemiológica (contato com água/lama de enchente, atividade ocupacional de risco)
- Caracterização da febre e mialgia (localização típica em panturrilhas)
- Sintomas oculares (hiperemia conjuntival)
- Sintomas de gravidade: sangramentos, dispneia, diminuição do débito urinário
- Presença de casos semelhantes em contatos/colegas de trabalho
- Uso de equipamentos de proteção individual no trabalho

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Avaliação de icterícia e sua tonalidade característica
- Pesquisa de sufusão conjuntival
- Palpação de panturrilhas avaliando mialgia
- Avaliação de hepatomegalia
- Ausculta pulmonar buscando sinais de comprometimento hemorrágico pulmonar
- Pesquisa de sinais de sangramento cutâneo-mucoso

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Função renal (ureia e creatinina)	Avaliar insuficiência renal aguda, achado central na síndrome de Weil	Elevadas, compatíveis com lesão renal aguda
Bilirrubinas e transaminases	Avaliar padrão de icterícia e função hepática	Bilirrubina elevada com predomínio de direta, transaminases pouco alteradas em relação à bilirrubina (padrão típico)
CPK (creatinofosfoquinase)	Avaliar rabdomiólise associada à mialgia intensa	Elevada
Hemograma completo (plaquetas)	Avaliar plaquetopenia, marcador de gravidade e risco hemorrágico	Plaquetopenia presente
Sorologia IgM ou PCR para leptospira (não deve atrasar o início do tratamento)	Confirmação diagnóstica, sem postergar a conduta terapêutica em quadro sugestivo	Reagente, confirmando o diagnóstico

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: antibioticoterapia com penicilina cristalina intravenosa (ou ceftriaxona) para formas graves, iniciada o quanto antes, mesmo antes da confirmação sorológica diante de quadro clínico-epidemiológico sugestivo; suporte hemodinâmico e correção de distúrbios hidroeletrolíticos
- Não farmacológica: internação hospitalar obrigatória, com avaliação de necessidade de terapia renal substitutiva (diálise) diante de insuficiência renal significativa; monitorização rigorosa de sinais de sangramento e função pulmonar
- Orientações ao paciente: explicar a gravidade do quadro e a necessidade de internação; orientar sobre a origem da doença (contato com água/urina de roedores contaminada) e medidas de proteção individual futura (uso de botas, luvas em atividades de risco); notificar compulsoriamente o caso à vigilância epidemiológica

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar a gravidade do quadro de forma clara, reconhecendo a necessidade de internação imediata
- Explicar a relação entre a exposição ocupacional e a doença, sem culpabilizar o paciente
- Orientar sobre medidas de proteção individual para o trabalho futuro
- Acolher a preocupação financeira/laboral do paciente diante da necessidade de afastamento

ERROS CRÍTICOS

- Não considerar leptospirose diante do contexto epidemiológico claro (exposição a água de enchente) associado a febre, mialgia e icterícia
- Aguardar confirmação sorológica antes de iniciar antibioticoterapia em quadro grave sugestivo
- Não avaliar função renal e não reconhecer insuficiência renal aguda associada
- Não indicar internação hospitalar diante de sinais de gravidade (icterícia, insuficiência renal, plaquetopenia)
- Não notificar compulsoriamente o caso à vigilância epidemiológica

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #283 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre, mialgia intensa e olhos avermelhados após enchente

CHECKLIST — FEBRE, MIALGIA E OLHOS AVERMELHADOS APÓS ENCHENTE (LEPTOSPIROSE)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Explicou a relação entre a exposição ocupacional e a doença, sem culpabilizar o paciente Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou exposição a água/lama de enchente Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou ativamente sobre sangramentos e dispneia (sinais de gravidade) Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou outros casos entre colegas de trabalho Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Identificou sufusão conjuntival e mialgia em panturrilhas Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou icterícia e hepatomegalia Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou função renal, CPK, bilirrubinas e plaquetas Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Reconheceu o quadro clínico-epidemiológico sem aguardar sorologia para agir Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA	Pts	Avaliação
Iniciou antibioticoterapia (penicilina cristalina/ceftriaxona) sem aguardar confirmação sorológica Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou internação hospitalar diante dos sinais de gravidade Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Notificou compulsoriamente o caso Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **9,5** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #284 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Febre e dor articular intensa e incapacitante

CENÁRIO

Consulta de demanda espontânea na UBS, em período de circulação simultânea de arboviroses na região.

PACIENTE

Cristina Almeida Ferraz, 52 anos, sexo feminino, costureira.

QUEIXA PRINCIPAL

Febre e dor articular intensa e incapacitante em mãos, punhos e joelhos há 3 dias.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, diferenciando de outras arboviroses.
2. Realize o exame físico geral e articular dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e os diferenciais.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha o tratamento sintomático e oriente sobre a evolução da doença.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #284 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Febre e dor articular intensa e incapacitante

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura	IMC
126/80 mmHg	90 bpm	16 irpm	38,4 °C	74 kg	1,60 m	28,9 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, febril, com fácies de dor, dificuldade para movimentar as mãos.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ARTICULAÇÕES: edema e dor à palpação em punhos, articulações interfalangeanas de ambas as mãos e joelhos, de forma simétrica, sem sinais de artrite séptica (sem calor/rubor intensos localizados); limitação funcional importante para realizar movimentos finos.
- PELE: exantema maculopapular discreto em tronco e membros.
- LINFONODOS: sem linfadenopatia significativa.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemograma completo	Leucócitos 5.200/mm³, plaquetas 210.000/mm³	Discretamente diferente do padrão leucopênico/plaquetopênico mais marcante da dengue
Teste rápido/sorologia IgM para chikungunya	**Reagente**	Não reagente
Teste rápido NS1/sorologia para dengue	Não reagente	Não reagente
PCR (Proteína C reativa)	**32 mg/L**	< 5 mg/L

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #284 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Febre e dor articular intensa e incapacitante

NOTA AO AVALIADOR

Reforçar que hemograma relativamente preservado (sem leucopenia/plaquetopenia marcantes) e artralgia simétrica intensa e incapacitante, desproporcional aos outros sintomas, são pistas importantes para diferenciar chikungunya de dengue neste contexto de epidemia simultânea de arboviroses.

PERFIL DO PACIENTE

Costureira, trabalho manual que depende muito da mobilidade das mãos, o que está sendo bastante impactado pela dor articular atual. Refere que vários vizinhos da rua também tiveram sintomas parecidos recentemente.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), estou com febre e uma dor terrível nas juntas, principalmente nas mãos e nos joelhos, não consigo nem fechar a mão direito.”
Sobre a dor articular	“É uma dor muito forte, simétrica dos dois lados, e incha bastante as juntas. Não consigo trabalhar costurando por causa disso.”
Sobre a febre	“A febre começou junto com a dor nas juntas, ficou em torno de 38-39°C nesses 3 dias.”
Sobre exantema	“Notei umas manchinhas vermelhas no corpo também, mas não coçam muito.”
Sobre epidemiologia	“Vários vizinhos aqui perto tiveram sintomas parecidos nas últimas semanas, tem bastante mosquito na região.”
Pergunta ativa — prognóstico	“Doutor(a), essa dor nas juntas vai passar? Vou conseguir voltar a costurar logo?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Tem osteoartrite leve prévia em joelhos, o que pode confundir com piora da doença de base, mas a dor atual é claramente mais intensa e generalizada — só revela essa condição prévia se perguntada sobre doenças articulares prévias
- Está preocupada com a possibilidade de a dor articular se tornar crônica, pois ouviu relatos de vizinhos que "nunca mais ficaram bons" após chikungunya — só revela essa preocupação se o candidato explorar expectativas sobre a evolução
- Depende integralmente da renda do trabalho de costura para sustento próprio, o que aumenta sua ansiedade quanto ao afastamento — só revela se o candidato perguntar sobre impacto funcional/ocupacional
- Notou que a dor piora bastante pela manhã, com rigidez articular matinal significativa — só revela se perguntada especificamente sobre padrão de rigidez matinal

COMPORTAMENTO DO ATOR

Demonstrar dificuldade real de movimentação das mãos (mímica de dificuldade para fechar a mão, gestos limitados). Franzir o rosto durante a palpação das articulações. Ansiosa sobre a possibilidade de dor crônica e impacto no trabalho.

GABARITO

Infectologia · Estação #284 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Febre e dor articular intensa e incapacitante

Chikungunya, fase aguda, com poliartralgia/artrite simétrica intensa e incapacitante como manifestação predominante.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Dengue — entra como diferencial de síndrome febril aguda em contexto de epidemia simultânea de arboviroses; sai pela predominância marcante de artralgia/artrite simétrica intensa (mais característica de chikungunya) e pela sorologia positiva especificamente para chikungunya, com NS1/sorologia para dengue negativos.
- Zika vírus — entra como diferencial de síndrome febril exantemática; sai pela artralgia geralmente mais leve na infecção por zika, comparada à intensidade e ao caráter incapacitante observados neste caso, mais típico de chikungunya.
- Artrite reumatoide (surto agudo) — entra pela poliartrite simétrica em mãos; sai pelo contexto epidemiológico agudo, febre concomitante e confirmação sorológica de chikungunya, tornando uma artropatia infecciosa aguda o diagnóstico mais provável neste momento.
- Febre reumática — entra como diferencial de poliartrite; sai pela faixa etária da paciente e pelo contexto epidemiológico claro de arbovirose, tornando esse diagnóstico pouco provável.

CONTEXTO CLÍNICO

A febre de chikungunya é uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus, caracterizada por artralgia/artrite intensa e frequentemente incapacitante, que a diferencia clinicamente da dengue, embora ambas possam circular simultaneamente na mesma região e período, exigindo diagnóstico diferencial cuidadoso. Uma parcela significativa dos pacientes evolui com sintomas articulares persistentes por semanas a meses (forma subaguda/crônica), com impacto funcional importante, como temido por esta paciente costureira.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de chikungunya é sustentado pela apresentação clínica característica de febre associada a poliartralgia/artrite simétrica intensa e incapacitante em pequenas e grandes articulações, com exantema associado, hemograma relativamente preservado (diferentemente do padrão leucopênico/plaquetopênico mais marcante da dengue), confirmado pela sorologia IgM reagente para chikungunya com exames para dengue negativos.

ANAMNESE ESPERADA

- Caracterização da febre e sua relação temporal com a dor articular
- Caracterização da dor articular (localização, simetria, intensidade, impacto funcional)
- Presença de exantema
- Contexto epidemiológico (casos na vizinhança, presença de mosquitos)
- Impacto funcional/ocupacional da artralgia
- Doenças articulares prévias que possam confundir o quadro

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Aferição de temperatura
- Exame articular detalhado, avaliando simetria, edema, calor e limitação funcional
- Inspeção de pele buscando exantema
- Avaliação de sinais de alarme para excluir dengue concomitante (embora possa haver coinfecção, deve-se avaliar ativamente)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Sorologia IgM ou teste rápido para chikungunya	Confirmação diagnóstica específica	Reagente

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Teste rápido NS1/sorologia para dengue	Diagnóstico diferencial e exclusão de coinfecção, dado o contexto de circulação simultânea de arboviroses	Auxilia a diferenciar as duas condições
Hemograma completo	Auxiliar na diferenciação com dengue, que tipicamente cursa com leucopenia e plaquetopenia mais marcantes	Geralmente mais preservado que na dengue

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: analgesia e anti-inflamatório para controle da dor articular na fase aguda (uso de AINEs pode ser considerado após exclusão segura de dengue, dado o risco de sangramento nesta última); paracetamol como opção mais segura enquanto houver dúvida diagnóstica entre as arboviroses
- Não farmacológica: repouso das articulações acometidas na fase aguda; fisioterapia pode ser considerada em casos de evolução para forma subaguda/crônica com limitação funcional persistente
- Orientações ao paciente: explicar a diferença entre chikungunya e dengue de forma acessível; alertar sobre a possibilidade de persistência da dor articular por semanas a meses (forma subaguda/crônica) em parcela significativa dos pacientes, sem gerar pânico, mas preparando para essa possibilidade; orientar retorno caso surjam sinais de alarme que sugiram dengue associada

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma didática a diferença entre chikungunya e dengue, já que a paciente pode ter ouvido falar apenas em dengue na comunidade
- Acolher a preocupação da paciente quanto ao impacto no trabalho manual
- Preparar realisticamente para a possibilidade de sintomas articulares prolongados, sem gerar desespero
- Verificar compreensão das orientações de tratamento sintomático

ERROS CRÍTICOS

- Não diferenciar clinicamente chikungunya de dengue, especialmente quanto ao uso de AINEs (que devem ser evitados enquanto dengue não for excluída)
- Não solicitar exames que auxiliem a diferenciação entre as arboviroses circulantes
- Não orientar sobre a possibilidade de evolução para forma subaguda/crônica com sintomas articulares persistentes
- Minimizar o impacto funcional da doença sem considerar orientações de suporte (repouso articular, fisioterapia futura)
- Prescrever AINEs sem primeiro considerar/excluir razoavelmente dengue concomitante em área de circulação simultânea

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #284 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Febre e dor articular intensa e incapacitante

CHECKLIST — FEBRE E DOR ARTICULAR INCAPACITANTE (CHIKUNGUNYA)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Explicou de forma didática a diferença entre chikungunya e dengue Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Chikungunya	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Acolheu a preocupação da paciente quanto ao impacto no trabalho manual CFM Res. 2.217/2018	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Caracterizou a artralgia (simetria, intensidade, impacto funcional) Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Chikungunya	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou contexto epidemiológico (casos na vizinhança) Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Examinou as articulações avaliando edema e simetria Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Chikungunya	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Inspecionou a pele buscando exantema Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou sorologia/teste específico para chikungunya Ministério da Saúde — Guia de Manejo Clínico de Chikungunya	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou exames para diferenciar de dengue (NS1, hemograma) Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Evitou AINEs até exclusão razoável de dengue, preferindo paracetamol Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou sobre possível evolução para forma subaguda/crônica Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou repouso articular na fase aguda Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **8,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #285 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia

CENÁRIO

Atendimento no Pronto-Socorro, paciente retornando de viagem à região amazônica.

PACIENTE

Diego Martins Rocha, 33 anos, sexo masculino, engenheiro ambiental.

QUEIXA PRINCIPAL

Febre alta em ciclos, associada a calafrios intensos e sudorese, há cerca de 5 dias, iniciada após retorno de viagem de trabalho.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, com atenção à história de viagem.
2. Realize o exame físico geral dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e os diferenciais.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha o tratamento específico conforme a espécie identificada.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #285 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
110/70 mmHg	102 bpm	18 irpm	39,4 °C (no momento do pico febril)	77 kg	1,79 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, no momento do exame em fase de calafrio intenso seguido de sudorese profusa, palidez leve.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: discreta esplenomegalia palpável, indolor; sem hepatomegalia significativa.
- PELE: sem exantema.
- Padrão da febre relatado pelo paciente: picos febris a cada 48 horas aproximadamente, com fase de calafrio, seguida de febre alta e depois sudorese intensa com melhora transitória (acessos malaricos).

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Gota espessa (exame parasitológico)	**Positiva, com identificação de trofozoítos de Plasmodium vivax**	Negativa
Hemograma completo	**Hemoglobina 11,8 g/dL, plaquetas 118.000/mm³**	Hb ≥ 13 g/dL (homens); plaquetas 150.000 – 450.000/mm³
Bilirrubina total	**2,1 mg/dL (predomínio indireto)**	< 1,2 mg/dL

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #285 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia

NOTA AO AVALIADOR

A gota espessa é o exame padrão-ouro e deve ser entregue com a identificação da espécie assim que solicitada — a espécie (P. vivax, neste caso) determina o esquema terapêutico específico a ser prescrito.

PERFIL DO PACIENTE

Engenheiro ambiental, viajou a trabalho para área rural da Amazônia por 3 semanas, retornando há 6 dias. Não fez uso de quimioprofilaxia antimalárica antes da viagem. Refere picadas frequentes de mosquito durante a estadia, principalmente ao entardecer.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), estou com uma febre muito alta que vem em ciclos, com calafrios fortes, depois vem a febre, e depois eu suo muito e melhoro por um tempo, mas volta.”
Sobre o padrão da febre	“Percebi que os episódios vêm a cada 2 dias, mais ou menos, sempre no mesmo padrão: calafrio, febre alta, depois suor.”
Sobre viagem recente	“Voltei há uns 6 dias de uma viagem de trabalho para uma área bem no meio da Amazônia, fiquei lá umas 3 semanas.”
Sobre profilaxia	“Não tomei nenhum remédio preventivo antes de viajar, não sabia que precisava.”
Sobre picadas de mosquito	“Fui bastante picado por mosquitos lá, principalmente no final da tarde e à noite, a região tinha muito mosquito.”
Sobre sintomas associados	“Sinto dor de cabeça forte durante a febre, e um cansaço muito grande depois que passa a crise.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“Doutor(a), o que eu peguei lá? Isso tem cura? Posso ter complicado alguma coisa?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Notou um leve amarelamento dos olhos que não valorizou, sinal de hemólise associada — só revela se perguntado especificamente sobre alterações na cor dos olhos/pele
- Um colega de trabalho que viajou junto também apresentou sintomas parecidos após o retorno — só revela se perguntado sobre outras pessoas do grupo de viagem com sintomas semelhantes
- Está preocupado com a possibilidade de ter uma forma grave da doença, pois um conhecido teve complicações graves de malária no passado — só revela essa preocupação se o candidato acolher a situação
- Não sabe diferenciar malária de dengue e está confuso sobre os dois diagnósticos possíveis — verbaliza essa confusão se o candidato não esclarecer bem

COMPORTAMENTO DO ATOR

Durante a simulação, pode demonstrar (verbalmente) as fases do "acesso malárico" — calafrio, depois febre, depois sudorese — como se estivesse passando por um ciclo durante a consulta. Fadiga visível após descrever uma crise. Curioso e ansioso para entender o diagnóstico.

GABARITO

Infectologia · Estação #285 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia

Malária por Plasmodium vivax, forma não complicada, confirmada por gota espessa.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Dengue — entra como diferencial de síndrome febril aguda; sai pelo padrão cíclico característico da febre (paroxismos a cada 48h no caso de P. vivax) e pela confirmação parasitológica na gota espessa, além do contexto epidemiológico de viagem a área endêmica de malária.
- Febre tifoide — entra como diferencial de febre em viajante; sai pela ausência do padrão em "escada" característico da febre tifoide e pela confirmação da gota espessa positiva para Plasmodium.
- Leptospirose — entra como diferencial de síndrome febril com icterícia leve; sai pela ausência de exposição a água contaminada/enchente e pela confirmação parasitológica específica de malária.
- Febre amarela — entra como diferencial em viajante para área amazônica com febre e icterícia leve; sai pela confirmação da gota espessa positiva para malária, tornando esse o diagnóstico confirmado, embora o status vacinal para febre amarela deva sempre ser verificado em viajantes para a região.

CONTEXTO CLÍNICO

A malária é uma doença parasitária transmitida pela picada do mosquito Anopheles, endêmica principalmente na região amazônica no Brasil. O Plasmodium vivax é a espécie mais prevalente no país, causando tipicamente febre terçã (paroxismos a cada 48 horas), com potencial de recaídas tardias pela persistência de formas hepáticas latentes (hipnozoítos) se não tratado adequadamente com esquema que inclua radical cura.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de malária por P. vivax é confirmado pela gota espessa positiva com identificação da espécie, associado ao quadro clínico característico de febre cíclica com calafrios, seguida de sudorese profusa (acessos malaricos), esplenomegalia e sinais discretos de hemólise (bilirrubina indireta elevada, anemia leve), em paciente com história epidemiológica compatível (viagem recente a área endêmica sem quimioprofilaxia).

ANAMNESE ESPERADA

- História detalhada de viagem (local, tempo de permanência, data de retorno)
- Uso de quimioprofilaxia antimalárica
- Caracterização do padrão da febre (cíclico, calafrios, sudorese)
- Sintomas associados (cefaleia, mialgia, icterícia)
- Outras pessoas do grupo de viagem com sintomas semelhantes
- Sinais de gravidade (alteração de consciência, dispneia, oligúria, sangramentos)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Aferição de temperatura durante os diferentes momentos do ciclo febril, se possível
- Palpação abdominal avaliando esplenomegalia/hepatomegalia
- Avaliação de icterícia
- Avaliação do nível de consciência e sinais de gravidade

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Gota espessa (exame parasitológico padrão-ouro)	Confirmar o diagnóstico e identificar a espécie de Plasmodium, essencial para definir o esquema terapêutico	Positiva, com identificação da espécie (P. vivax neste caso)
Teste rápido para malária (quando disponível, complementar à gota espessa)	Diagnóstico rápido complementar, especialmente em locais sem microscopista disponível imediatamente	Positivo para a espécie identificada

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Hemograma completo e bilirrubinas	Avaliar repercussão hematológica (anemia, plaquetopenia) e hemólise associada	Anemia leve, plaquetopenia e bilirrubina indireta elevada, compatíveis com hemólise
Função renal e hepática (em casos com sinais de gravidade)	Rastrear complicações de formas graves, especialmente por P. falciparum, embora menos frequentes com P. vivax	Normal na forma não complicada

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: esquema de tratamento específico para P. vivax conforme protocolo do Ministério da Saúde, combinando cloroquina (ação esquizonticida sanguínea) associada à primaquina (ação sobre hipnozoítos hepáticos, para "cura radical" e prevenção de recaídas), respeitando contraindicações (deficiência de G6PD deve ser investigada antes do uso de primaquina, quando possível)
- Não farmacológica: acompanhamento clínico ambulatorial na forma não complicada, com orientação de retorno caso surjam sinais de gravidade
- Orientações ao paciente: explicar a importância de completar o esquema terapêutico completo, incluindo a primaquina, para evitar recaídas tardias por persistência de formas hepáticas; notificar compulsoriamente o caso à vigilância epidemiológica; orientar sobre prevenção em viagens futuras (quimioprofilaxia quando indicada, repelentes, mosquiteiros)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma didática o ciclo da doença e por que a febre ocorre em padrões cíclicos característicos
- Esclarecer a diferença entre malária e outras doenças febris que o paciente possa confundir (ex.: dengue)
- Reforçar a importância de completar todo o esquema terapêutico, incluindo a fase de prevenção de recaídas
- Orientar sobre prevenção para viagens futuras à região endêmica

ERROS CRÍTICOS

- Não investigar história de viagem para área endêmica em paciente com febre, atrasando o diagnóstico
- Não solicitar gota espessa (ou teste rápido) diante de suspeita de malária
- Prescrever esquema terapêutico incompleto, sem incluir primaquina para P. vivax, expondo o paciente a risco de recaída
- Não notificar compulsoriamente o caso à vigilância epidemiológica
- Não orientar sobre prevenção (quimioprofilaxia, repelentes) para viagens futuras a áreas endêmicas

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #285 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Febre com calafrios em ciclos após viagem à Amazônia

CHECKLIST — FEBRE COM CALAFRIOS EM CICLOS APÓS VIAGEM À AMAZÔNIA (MALÁRIA)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Explicou de forma didática o ciclo da doença e o padrão cíclico da febre Ministério da Saúde — Guia de Tratamento da Malária	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou história de viagem recente a área endêmica Ministério da Saúde — Guia de Tratamento da Malária	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre uso de quimioprofilaxia antes da viagem Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Caracterizou o padrão cíclico da febre (calafrio-febre-sudorese) Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Palpou o abdome buscando esplenomegalia Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Avaliou icterícia/palidez Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou gota espessa com identificação da espécie Ministério da Saúde — Guia de Tratamento da Malária	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Prescreveu cloroquina associada a primaquina para P. vivax (esquema completo) Ministério da Saúde — Guia de Tratamento da Malária	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Considerou investigar deficiência de G6PD antes da primaquina Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Notificou compulsoriamente o caso e orientou prevenção para viagens futuras Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **8,5** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #286 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí

CENÁRIO

Atendimento no Pronto-Socorro, surto familiar após consumo de suco de açaí artesanal em área endêmica.

PACIENTE

Eduardo Nascimento Batista, 19 anos, sexo masculino, estudante.

QUEIXA PRINCIPAL

Febre prolongada há 12 dias, associada a inchaço ao redor de um dos olhos, iniciados após consumo de suco de açaí artesanal em casa de parentes na zona rural.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, com atenção à história epidemiológica alimentar.
2. Realize o exame físico geral dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e os diferenciais.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha o tratamento específico e as medidas de vigilância epidemiológica.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #286 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
104/68 mmHg	108 bpm	18 irpm	38,6 °C	68 kg	1,75 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, febril, com edema periorbitário unilateral visível, discreto emagrecimento.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- FACE: edema bipalpebral unilateral (olho esquerdo), indolor, sem hiperemia importante (sinal de Romaña).
- LINFONODOS: linfadenopatia generalizada discreta.
- ABDOME: hepatoesplenomegalia leve, indolor à palpação.
- CARDIOVASCULAR: taquicardia sinusal, bulhas rítmicas, sem sopros no momento.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Pesquisa direta de tripomastigotas no sangue periférico (exame a fresco)	**Positiva, com visualização de formas tripomastigotas móveis**	Negativa
Hemograma completo	**Leucocitose com linfocitose relativa, sem eosinofilia importante**	Padrão variável; linfocitose pode ocorrer na fase aguda
Eletrocardiograma	Taquicardia sinusal, sem alterações de condução ou repolarização no momento	Ritmo sinusal normal

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #286 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí

NOTA AO AVALIADOR

A pesquisa direta do parasita no sangue (método parasitológico direto) é o exame de escolha na fase aguda, com alta sensibilidade neste período — deve ser priorizada em relação à sorologia, que tem maior utilidade na fase crônica. Entregar o resultado assim que solicitado.

PERFIL DO PACIENTE

Estudante, visitou parentes em área rural há cerca de 2 semanas, onde consumiu suco de açaí artesanal preparado de forma caseira, sem processamento industrial adequado. Outros familiares que consumiram o mesmo suco também apresentaram sintomas semelhantes (febre prolongada).

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), estou com febre há quase 2 semanas, não passa, e meu olho esquerdo inchou bastante, sem eu ter batido nem nada.”
Sobre o inchaço no olho	“Foi bem estranho, o olho ficou inchado do nada, sem doer muito, só o inchaço mesmo.”
Sobre alimentação recente	“Fui visitar uns parentes na roça há umas 2 semanas, e lá bebemos um suco de açaí bem caseiro, feito na hora, de uma polpa que eles mesmos bateram.”
Sobre outros casos na família	“É engraçado que minha prima e meu tio, que também beberam o mesmo suco, ficaram com febre parecida depois.”
Sobre sintomas associados	“Sinto um cansaço grande, e umas "ínguas" pelo corpo, além dessa febre que não passa.”
Sobre sintomas cardíacos	“Às vezes sinto o coração meio acelerado, mas não sei se é da febre mesmo.”
Pergunta ativa — diagnóstico	“Doutor(a), o que é isso? Foi o açaí que causou? Isso tem cura?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Notou um pequeno nódulo endurecido perto do olho inchado, que corresponderia ao sinal de Romaña em fase inicial (chagoma de inoculação ocular) — só revela se perguntado especificamente sobre presença de nódulos/caroços na região
- Está com falta de ar leve ao subir escadas nos últimos dias, possível sinal de comprometimento miocárdico agudo (miocardite chagásica aguda) — só revela se perguntado ativamente sobre dispneia
- A casa dos parentes na zona rural tem barbeiros (triatomíneos) conhecidos na região, mas a família nunca associou isso a doenças — só revela se perguntado sobre condições de moradia dos parentes/presença de insetos
- Está confuso achando que "pegou uma alergia" do açaí, sem entender que pode ser uma doença infecciosa transmitida pelo alimento contaminado — verbaliza essa confusão espontaneamente

COMPORTAMENTO DO ATOR

Visivelmente preocupado com o inchaço no olho, toca a região repetidamente. Cansaço aparente ao longo da consulta. Curioso e um pouco confuso sobre a relação entre o consumo do açaí e a doença.

GABARITO

Infectologia · Estação #286 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí

Doença de Chagas aguda, provavelmente por transmissão oral (surto alimentar por consumo de açaí contaminado), com sinal de Romaña (porta de entrada ocular) e possível miocardite chagásica aguda associada.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Mononucleose infecciosa — entra pela associação de febre prolongada, linfadenopatia e hepatoesplenomegalia; sai pela confirmação parasitológica direta positiva para tripomastigotas e pelo contexto epidemiológico de surto alimentar característico.
- Toxoplasmose aguda — entra como diferencial de síndrome febril com linfadenopatia; sai pela presença específica do sinal de Romaña (edema bipalpebral unilateral) e pela confirmação parasitológica direta de Trypanosoma cruzi.
- Celulite periorbitária — entra pelo edema periorbitário unilateral; sai pela ausência de sinais flogísticos intensos (calor, rubor marcante, dor importante) e pelo contexto epidemiológico e sistêmico (febre prolongada, hepatoesplenomegalia, outros casos familiares) mais compatível com doença de Chagas aguda.
- Febre tifoide — entra como diferencial de febre prolongada; sai pela presença do sinal de Romaña característico e pela confirmação parasitológica direta específica.

CONTEXTO CLÍNICO

A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, classicamente transmitida pelo inseto vetor (triatomíneo, "barbeiro"), mas com surtos crescentes de transmissão oral no Brasil, especialmente na região amazônica, associados ao consumo de açaí e outros alimentos contaminados processados de forma artesanal inadequada. A fase aguda pode cursar com miocardite e, mais raramente, meningoencefalite, sendo potencialmente mais grave nos surtos de transmissão oral, que tendem a ter maior carga parasitária inoculada.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de doença de Chagas aguda é sustentado pela combinação de febre prolongada, sinal de Romaña (edema bipalpebral unilateral, porta de entrada ocular do parasita), linfadenopatia generalizada e hepatoesplenomegalia, associado ao contexto epidemiológico de surto alimentar (consumo de açaí artesanal compartilhado com outros familiares sintomáticos), confirmado pela pesquisa direta positiva de tripomastigotas no sangue periférico — método de escolha na fase aguda pela alta parasitemia circulante neste período.

ANAMNESE ESPERADA

- Caracterização da febre (duração, padrão)
- Presença e características do edema periorbitário (sinal de Romaña)
- História alimentar detalhada (consumo de açaí ou outros alimentos artesanais em área endêmica)
- Outros casos semelhantes entre familiares/contatos que compartilharam a mesma refeição
- Sintomas cardíacos (palpitações, dispneia) sugestivos de miocardite aguda
- Condições de moradia dos parentes visitados (presença de triatomíneos)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Inspeção facial detalhada buscando sinal de Romaña ou chagoma de inoculação
- Palpação de linfonodos
- Palpação abdominal avaliando hepatoesplenomegalia
- Ausculta cardíaca cuidadosa
- Avaliação de sinais de insuficiência cardíaca (dispneia, edema, turgência jugular)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Pesquisa direta de tripomastigotas no sangue periférico (exame a fresco ou método de concentração)	Exame de escolha na fase aguda, dada a alta parasitemia circulante neste período	Positivo, confirmando o diagnóstico
Eletrocardiograma	Rastrear miocardite chagásica aguda, complicação temida da fase aguda	Pode mostrar alterações de repolarização, distúrbios de condução ou taquicardia sinusal isolada
Ecocardiograma (em casos com sintomas cardíacos ou ECG alterado)	Avaliar função miocárdica diante de suspeita de miocardite aguda	Avaliar presença de disfunção ventricular associada
Hemograma completo	Avaliar padrão inflamatório/linfocitose associada à fase aguda	Leucocitose com linfocitose relativa

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: iniciar tratamento específico com benznidazol o mais precocemente possível, medicamento de escolha na fase aguda, com maior taxa de cura nesta fase da doença; monitorização de efeitos adversos do tratamento (reações cutâneas, alterações hematológicas)
- Não farmacológica: internação para monitorização cardíaca se houver sinais de miocardite aguda; investigação e acompanhamento dos demais familiares que compartilharam a mesma refeição, mesmo que assintomáticos no momento
- Orientações ao paciente: explicar a relação causal entre o consumo do açaí artesanal contaminado e a doença, orientando sobre a importância do processamento adequado (pasteurização) de polpas de açaí para prevenção; notificar compulsoriamente o caso e o surto à vigilância epidemiológica; explicar a importância do tratamento precoce para maior chance de cura parasitológica

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma clara a relação entre o alimento consumido e a doença, desconstruindo a confusão inicial do paciente com "alergia"
- Comunicar a necessidade de avaliação dos demais familiares expostos ao mesmo alimento
- Explicar a importância do tratamento precoce e específico
- Acolher a preocupação do paciente quanto ao prognóstico

ERROS CRÍTICOS

- Não investigar história alimentar detalhada (consumo de açaí/outros alimentos artesanais) diante de febre prolongada em área endêmica
- Não reconhecer o sinal de Romaña como achado característico de doença de Chagas aguda
- Não solicitar pesquisa direta do parasita (exame de escolha na fase aguda) e optar apenas por sorologia, menos sensível nesta fase
- Não avaliar comprometimento cardíaco (ECG) diante de suspeita de doença de Chagas aguda
- Não notificar o surto e não orientar avaliação dos demais familiares expostos ao mesmo alimento

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #286 · PS — Pronto-Socorro · nível difícil

Febre prolongada e inchaço ao redor do olho após consumo de açaí

CHECKLIST — FEBRE PROLONGADA E INCHAÇO NO OLHO APÓS AÇAÍ (DOENÇA DE CHAGAS AGUDA)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Explicou a relação entre o alimento consumido e a doença, desconstruindo a ideia de "alergia" Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou história alimentar (consumo de açaí artesanal) Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre outros casos entre familiares que compartilharam o alimento Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou sintomas cardíacos (palpitações, dispneia) Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Identificou o sinal de Romaña (edema bipalpebral unilateral) Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Realizou ausculta cardíaca cuidadosa Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou pesquisa direta do parasita no sangue (método de escolha na fase aguda) Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou ECG para rastrear miocardite aguda Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Iniciou benznidazol precocemente Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Notificou o surto e orientou avaliação dos demais familiares expostos Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **8,5** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #287 · Ambulatório — Pré-natal de Alto Risco · nível difícil

Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal

CENÁRIO

Consulta de retorno no ambulatório de pré-natal para avaliação de resultado de sorologia de rotina.

PACIENTE

Vanderleia Souza Prado, 26 anos, sexo feminino, veterinária, 16 semanas de gestação.

QUEIXA PRINCIPAL

Retorna para avaliação de sorologias do primeiro trimestre, assintomática.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, incluindo fatores de risco para toxoplasmose.
2. Interprete corretamente o resultado sorológico apresentado.
3. Formule a conduta diagnóstica adicional necessária para confirmar infecção aguda.
4. Solicite os exames complementares adequados para avaliar risco fetal.
5. Proponha o tratamento e as orientações preventivas.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #287 · Ambulatório — Pré-natal de Alto Risco · nível difícil

Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
110/70 mmHg	78 bpm	16 irpm	36,4 °C	64 kg	1,62 m

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, assintomática, sem febre ou linfadenopatia palpável no momento do exame.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME/ÚTERO: altura uterina compatível com idade gestacional; batimentos cardiofetais presentes, rítmicos, 152 bpm.
- LINFONODOS: sem linfadenopatia cervical palpável no momento.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
IgM para toxoplasmose (sorologia de rotina do 1º trimestre)	**Reagente**	Não reagente
IgG para toxoplasmose	**Reagente, com teste de avidez de IgG**	Avidez alta sugere infecção antiga (>4 meses); avidez baixa sugere infecção recente
Teste de avidez de IgG	**Avidez baixa (0,18)**	Avidez alta (>0,3) exclui infecção nos últimos 3-4 meses; avidez baixa é compatível com infecção recente

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #287 · Ambulatório — Pré-natal de Alto Risco · nível difícil

Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal

NOTA AO AVALIADOR

O teste de avidez de IgG é fundamental para datar a infecção em relação à gestação e deve ser solicitado sempre que IgM e IgG estiverem reagentes em gestante — reforçar essa conduta se o candidato não pensar em solicitá-lo espontaneamente.

PERFIL DO PACIENTE

Veterinária, trabalha em clínica que atende animais domésticos, incluindo gatos. Tem dois gatos em casa. Refere gostar de preparar carnes mal passadas e já teve contato com jardinagem sem luvas recentemente.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Ao ser informada do resultado	“Doutor(a), o resultado do meu exame de toxoplasmose deu alterado? Isso é grave para o bebê?”
Sobre sintomas	“Não senti nada de diferente, nenhuma febre, nenhum gânglio inchado, estou me sentindo bem.”
Sobre exposição a gatos	“Trabalho numa clínica veterinária, mexo com gatos o tempo todo, e também tenho dois gatos em casa.”
Sobre hábitos alimentares	“Confesso que gosto de comer carne mal passada, principalmente carne bovina.”
Sobre jardinagem	“Mexo na terra do jardim de vez em quando, às vezes sem luva mesmo.”
Sobre exames prévios de toxoplasmose	“Não sei se já tive contato com toxoplasmose antes dessa gestação, nunca tinha feito esse exame.”
Pergunta ativa — risco fetal	“Doutor(a), meu bebê pode ter problemas por causa disso? O que eu faço agora?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Teve um episódio de mal-estar leve com "gânglios inchados" no pescoço há cerca de 6-8 semanas, que atribuiu a uma gripe e não valorizou — só revela se perguntada ativamente sobre sintomas nas últimas semanas
- Limpa a caixa de areia dos gatos diariamente, geralmente sem luvas — só revela detalhes específicos se perguntada sobre manuseio da caixa de areia
- Está com muito medo de precisar interromper a gestação por causa do diagnóstico — verbaliza esse medo se o candidato não esclarecer adequadamente as opções e o real risco
- Não lava sempre bem as mãos após manusear terra do jardim antes de comer — só revela esse detalhe se perguntada sobre higiene após contato com terra

COMPORTAMENTO DO ATOR

Muito ansiosa ao ouvir sobre o resultado alterado, focada principalmente no risco para o bebê. Colaborativa ao fornecer informações sobre hábitos quando perguntada diretamente. Alívio gradual conforme recebe explicações claras sobre a conduta.

GABARITO

Infectologia · Estação #287 · Ambulatório — Pré-natal de Alto Risco · nível difícil

Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal

Toxoplasmose aguda provavelmente adquirida no início da gestação (IgM e IgG reagentes com avidez de IgG baixa, sugerindo infecção recente, possivelmente coincidindo com quadro de mal-estar/linfadenopatia relatado 6-8 semanas antes), exigindo avaliação de risco de transmissão vertical.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Infecção antiga (antes da gestação) com IgM residual — entra como possibilidade em toda gestante com IgM reagente; sai pela avidez de IgG baixa, que sugere infecção mais recente (dentro dos últimos 3-4 meses), reforçando a necessidade de considerar infecção aguda gestacional.
- Falso-positivo de IgM (reação cruzada) — entra como possibilidade a se considerar em sorologias de toxoplasmose; sai pela presença de história compatível (mal-estar com linfadenopatia há 6-8 semanas) e pela avidez baixa corroborando o quadro, embora a confirmação em laboratório de referência possa ser considerada em casos de dúvida.
- Mononucleose infecciosa como causa do episódio de linfadenopatia prévio — entra como diferencial do episódio de mal-estar relatado; sai pela sorologia específica confirmando toxoplasmose como explicação mais provável e relevante para a conduta obstétrica atual.

CONTEXTO CLÍNICO

A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, adquirida principalmente pelo consumo de carne crua/mal cozida contendo cistos, contato com fezes de gato contaminadas (hospedeiro definitivo) ou manuseio de terra contaminada. A infecção aguda na gestação pode resultar em transmissão vertical, com risco de toxoplasmose congênita (que pode causar corioretinite, calcificações cerebrais, hidrocefalia), sendo o risco de transmissão maior quanto mais avançada a gestação, mas a gravidade das sequelas fetais maior quanto mais precoce a infecção.

JUSTIFICATIVA

A suspeita de infecção aguda é sustentada pela positividade de IgM e IgG com teste de avidez de IgG baixo, sugerindo infecção adquirida dentro dos últimos 3-4 meses, compatível com o relato de mal-estar com linfadenopatia há 6-8 semanas — achados que, associados aos fatores de risco identificados (contato com gatos/caixa de areia, consumo de carne mal passada, manuseio de terra sem proteção), reforçam a suspeita de toxoplasmose aguda gestacional, exigindo tratamento e investigação de acometimento fetal.

ANAMNESE ESPERADA

- Sintomas sugestivos de toxoplasmose aguda (mal-estar, febre baixa, linfadenopatia) nas últimas semanas/meses
- Fatores de risco: contato com gatos e manuseio de fezes/caixa de areia, consumo de carne crua ou mal cozida, contato com terra/jardinagem sem proteção
- Idade gestacional no momento da provável infecção
- Resultados sorológicos prévios à gestação, se disponíveis

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação de linfonodos cervicais e outras cadeias
- Avaliação de sinais vitais maternos
- Ausculta de batimentos cardiofetais e medida de altura uterina

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Teste de avidez de IgG para toxoplasmose	Datar a infecção em relação à gestação — avidez alta exclui infecção recente, avidez baixa sugere infecção nos últimos 3-4 meses	Avidez baixa neste caso, compatível com infecção recente

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Ultrassonografia obstétrica morfológica seriada	Rastrear sinais sugestivos de toxoplasmose congênita (calcificações cerebrais, ventriculomegalia, hidrocefalia)	Acompanhamento seriado; pode ser normal ou apresentar alterações sugestivas
Amniocentese com PCR para Toxoplasma gondii no líquido amniótico (após 18 semanas e pelo menos 4 semanas após a provável infecção)	Confirmar ou excluir infecção fetal	Define conduta adicional conforme positividade ou negatividade

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: iniciar espiramicina imediatamente diante de suspeita de infecção aguda materna, medicamento que reduz o risco de transmissão vertical (não trata infecção fetal já estabelecida); caso a infecção fetal seja confirmada (PCR positivo no líquido amniótico) ou fortemente suspeita, considerar esquema combinado (sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico) conforme avaliação especializada, geralmente após o primeiro trimestre
- Não farmacológica: encaminhamento ao pré-natal de alto risco para acompanhamento conjunto; seguimento ultrassonográfico seriado
- Orientações ao paciente: explicar de forma clara o risco de transmissão vertical e a importância do tratamento em reduzir esse risco; esclarecer que a maioria das crianças com toxoplasmose congênita tratada adequadamente não desenvolve sequelas graves; orientar medidas preventivas para evitar reinfecção ou infecção de outros membros: evitar contato com fezes de gato (delegar limpeza da caixa de areia a outra pessoa, ou usar luvas e lavar bem as mãos), evitar consumo de carne crua/mal passada, usar luvas na jardinagem/manuseio de terra

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar o resultado de forma clara, mas acolhedora, evitando gerar pânico desproporcional
- Explicar de forma didática a diferença entre infecção materna e infecção fetal, e a importância do tratamento em reduzir (não eliminar) o risco de transmissão
- Esclarecer que a interrupção da gestação não é a conduta indicada apenas pela sorologia materna alterada
- Verificar compreensão das orientações preventivas

ERROS CRÍTICOS

- Não solicitar teste de avidez de IgG diante de IgM e IgG reagentes em gestante, deixando de datar adequadamente a infecção
- Não iniciar espiramicina prontamente diante de suspeita de toxoplasmose aguda gestacional
- Não encaminhar para investigação de acometimento fetal (USG seriada, consideração de amniocentese)
- Gerar pânico desproporcional sugerindo interrupção da gestação sem base em confirmação de acometimento fetal
- Não orientar medidas preventivas específicas (manuseio de caixa de areia, consumo de carne, jardinagem)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #287 · Ambulatório — Pré-natal de Alto Risco · nível difícil

Sorologia de toxoplasmose com IgM reagente no pré-natal

CHECKLIST — SOROLOGIA DE TOXOPLASMOSE COM IgM REAGENTE NO PRÉ-NATAL

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Comunicou o resultado sem gerar pânico desproporcional FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Esclareceu que a interrupção da gestação não é indicada apenas pela sorologia materna FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou contato com gatos/caixa de areia FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou consumo de carne crua/mal passada e manuseio de terra FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre sintomas nas últimas semanas (linfadenopatia, mal-estar) FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Avaliou linfonodos cervicais FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou teste de avidez de IgG para datar a infecção FEBRASGO	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou USG obstétrica seriada para rastrear sinais de infecção fetal FEBRASGO	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Iniciou espiramicina prontamente diante da suspeita de infecção aguda FEBRASGO / Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Encaminhou para investigação de acometimento fetal (amniocentese/PCR) FEBRASGO	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou medidas preventivas (manuseio de caixa de areia, carnes, jardinagem) FEBRASGO	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **8,5** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Infectologia · Estação #288 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica

CENÁRIO

Consulta de demanda espontânea na UBS de município endêmico para esquistossomose.

PACIENTE

José Carlos Pereira, 48 anos, sexo masculino, pescador.

QUEIXA PRINCIPAL

Diarreia intermitente há vários meses, associada a aumento progressivo do volume abdominal.

TAREFAS (10 MINUTOS)

1. Realize a anamnese dirigida, com atenção à história epidemiológica de exposição a águas.
2. Realize o exame físico geral e abdominal dirigido.
3. Formule a hipótese diagnóstica e classifique a fase da doença.
4. Solicite os exames complementares adequados.
5. Proponha o tratamento específico e as medidas de controle epidemiológico.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Infectologia · Estação #288 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura
124/80 mmHg	82 bpm	18 irpm	36,4 °C	68 kg (com perda ponderal referida)	1,70 m

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, emagrecido, com aumento do volume abdominal desproporcional ao restante do corpo.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: volumoso (ascite moderada, macicez móvel à percussão), com circulação colateral visível na parede abdominal ("cabeça de medusa" discreta); hepatomegalia de superfície irregular à palpação, com esplenomegalia associada (baço palpável a cerca de 6 cm do rebordo costal).
- PELE: sem lesões relevantes no momento; icterícia leve de escleras.

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Exame parasitológico de fezes (método de Kato-Katz)	**Positivo para ovos de Schistosoma mansoni**	Negativo
Hemograma completo	**Hemoglobina 10,2 g/dL, plaquetas 88.000/mm³, leucócitos com eosinofilia (12%)**	Hb ≥ 13 g/dL; plaquetas 150.000 – 450.000/mm³; eosinófilos < 5%
Coagulograma (TP/TTPA)	**Tempos discretamente prolongados**	Normais
Endoscopia digestiva alta (avaliação de varizes esofágicas)	**Presença de varizes esofágicas de médio calibre, sem sangramento ativo no momento**	Ausência de varizes

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Infectologia · Estação #288 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica

NOTA AO AVALIADOR

O exame parasitológico de fezes (Kato-Katz) é o exame inicial e deve ser solicitado assim que a hipótese for levantada. A ultrassonografia abdominal e a endoscopia digestiva alta são exames complementares para avaliar a gravidade da forma hepatoesplênica e devem ser entregues conforme solicitados, reforçando a necessidade de investigar hipertensão portal.

PERFIL DO PACIENTE

Pescador, mora à beira de rio conhecido por transmissão de esquistossomose na região, com contato frequente e prolongado com água doce ao longo de décadas. Refere episódios de diarreia intermitente há anos, que foram se agravando, e notou aumento progressivo do volume da barriga nos últimos meses.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor(a), tenho tido diarreia de vez em quando há muito tempo, mas ultimamente minha barriga cresceu bastante e isso está me preocupando.”
Sobre a diarreia	“Vem e volta, às vezes com um pouco de sangue misturado, há muitos anos, mas nunca dei muita importância.”
Sobre exposição a água	“Sou pescador, trabalho no rio praticamente todos os dias, desde criança, sempre entrei na água sem proteção.”
Sobre o aumento do abdome	“Minha barriga foi crescendo aos poucos nos últimos meses, e emagreci o resto do corpo, ficou tudo desproporcional.”
Sobre sintomas associados	“Sinto bastante cansaço, e às vezes um inchaço nas pernas também.”
Sobre sangramentos	“Uma vez vomitei um pouco de sangue, mas foi há uns meses, não fui ao médico na hora.”
Pergunta ativa — gravidade	“Doutor(a), o que é isso na minha barriga? É grave? Tem cura?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Teve um episódio de hematêmese (vômito com sangue) há alguns meses, sugestivo de sangramento de varizes esofágicas, que não valorizou adequadamente — só revela espontaneamente de forma vaga, mas confirma detalhes se perguntado diretamente sobre episódios de sangramento digestivo
- Vários vizinhos e colegas pescadores da mesma comunidade também têm "barriga d’água", sinal de alta endemicidade local não valorizada pela comunidade — só revela se perguntado sobre casos semelhantes na comunidade
- Nunca recebeu tratamento específico para esquistossomose antes, apesar de sintomas há anos, por falta de acesso a diagnóstico adequado — só revela se perguntado sobre tratamentos prévios
- Está com medo de ter "um problema no fígado muito grave, tipo câncer" — verbaliza esse medo se o candidato não esclarecer bem o diagnóstico

COMPORTAMENTO DO ATOR

Demonstrar cansaço e fragilidade física (emagrecido, fala mais devagar). Preocupado e um pouco assustado com o aumento do abdome e o episódio de sangramento. Colaborativo ao fornecer informações sobre exposição ocupacional quando perguntado.

GABARITO

Infectologia · Estação #288 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica

Esquistossomose mansônica, forma hepatoesplênica (fase crônica avançada), com hipertensão portal, varizes esofágicas e hiperesplenismo associado.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Cirrose hepática de outras etiologias (viral, alcoólica) — entra como causa de hepatoesplenomegalia e hipertensão portal; sai pela confirmação parasitológica positiva para Schistosoma mansoni e pelo contexto epidemiológico de exposição prolongada a águas de rio em área endêmica, tornando a esquistossomose a causa mais provável, embora causas associadas devam sempre ser investigadas.
- Doença hepática policística ou tumoral — entra como diferencial de hepatomegalia; sai pelo padrão de hepatomegalia com superfície irregular associada a esplenomegalia e hipertensão portal, mais compatível com fibrose periportal esquistossomótica (fibrose de Symmers) do que com doença focal.
- Tuberculose peritoneal — entra como diferencial de ascite crônica; sai pela positividade específica do exame parasitológico de fezes para esquistossomose e pelo contexto epidemiológico claro.
- Doença inflamatória intestinal crônica — entra pela diarreia crônica intermitente com sangue; sai pela confirmação parasitológica e pelo quadro sistêmico de hepatoesplenomegalia com hipertensão portal, mais compatível com esquistossomose avançada.

CONTEXTO CLÍNICO

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária causada pelo Schistosoma mansoni, transmitida pelo contato com água doce contaminada contendo o caramujo hospedeiro intermediário (gênero Biomphalaria), endêmica em diversas regiões do Brasil, especialmente Nordeste e áreas de rios do Sudeste/Norte. A forma crônica hepatoesplênica, resultante de anos de infecção não tratada, decorre da fibrose periportal (fibrose de Symmers) causada pela reação granulomatosa aos ovos do parasita retidos no fígado, levando à hipertensão portal pré-sinusoidal, com preservação relativa da função hepatocelular em fases iniciais.

JUSTIFICATIVA

O diagnóstico de esquistossomose mansônica forma hepatoesplênica é sustentado pela história de exposição prolongada a águas de rio em área endêmica, diarreia crônica intermitente com sangue, e confirmado pelo exame parasitológico de fezes positivo para ovos de S. mansoni, associado a achados de hipertensão portal (hepatoesplenomegalia, varizes esofágicas, hiperesplenismo com plaquetopenia e eosinofilia), caracterizando a forma avançada da doença que exige tratamento específico e manejo das complicações da hipertensão portal.

ANAMNESE ESPERADA

- História detalhada de exposição a águas doces (rios, lagos, açudes) em área endêmica e tempo de exposição
- Caracterização da diarreia crônica (presença de sangue, frequência, duração)
- Percepção do aumento do volume abdominal e perda de peso
- Sintomas de hipertensão portal (episódios de hematêmese/melena)
- Casos semelhantes na comunidade
- Tratamentos prévios para esquistossomose

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Inspeção e percussão abdominal avaliando ascite (macicez móvel)
- Palpação cuidadosa avaliando hepatomegalia (características de superfície) e esplenomegalia
- Pesquisa de circulação colateral abdominal
- Avaliação de icterícia e sinais de hepatopatia crônica
- Avaliação de sinais de anemia

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Exame parasitológico de fezes (Kato-Katz)	Exame padrão para diagnóstico e quantificação da carga parasitária	Positivo para ovos de S. mansoni
Ultrassonografia abdominal (com protocolo específico para esquistossomose, quando disponível)	Avaliar padrão de fibrose periportal e classificar a gravidade do acometimento hepático	Fibrose periportal, hepatoesplenomegalia
Endoscopia digestiva alta	Rastrear varizes esofágicas, complicação da hipertensão portal com risco de sangramento grave	Identificação e classificação das varizes, orientando necessidade de profilaxia
Hemograma completo	Avaliar eosinofilia (marcador de infecção parasitária ativa) e hiperesplenismo (plaquetopenia, anemia, leucopenia)	Eosinofilia e citopenias associadas ao hiperesplenismo

CONDUTA ESPERADA

- Farmacológica: praziquantel em dose única, tratamento específico para todas as formas de esquistossomose, incluindo a forma hepatoesplênica (reduz progressão da fibrose, embora não reverta fibrose já estabelecida); profilaxia de sangramento de varizes esofágicas conforme achado endoscópico (ligadura elástica ou betabloqueador não seletivo, conforme avaliação especializada)
- Não farmacológica: encaminhamento para acompanhamento especializado (hepatologia/gastroenterologia) para manejo da hipertensão portal e suas complicações; orientar medidas de prevenção de novos contatos com água contaminada quando possível
- Orientações ao paciente: explicar a relação entre a exposição prolongada à água do rio e a doença; esclarecer que o tratamento com praziquantel elimina o parasita, mas a fibrose hepática já instalada requer acompanhamento e manejo específico das complicações (varizes); notificar o caso e orientar rastreio de outros membros da comunidade com exposição semelhante

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma acessível a relação entre a exposição ocupacional à água do rio e a doença hepática desenvolvida ao longo dos anos
- Esclarecer que existe tratamento específico eficaz contra o parasita, desconstruindo o medo de câncer expresso pelo paciente
- Explicar a necessidade de acompanhamento contínuo devido às complicações já instaladas (hipertensão portal)
- Abordar a relevância comunitária do achado, dada a possível alta prevalência entre vizinhos/colegas

ERROS CRÍTICOS

- Não investigar história de exposição a águas doces em área endêmica diante de sintomas compatíveis
- Não solicitar exame parasitológico de fezes diante de suspeita de esquistossomose
- Não investigar hipertensão portal (endoscopia para varizes esofágicas) diante de hepatoesplenomegalia e história de hematêmese
- Prescrever apenas o tratamento com praziquantel sem encaminhar para manejo especializado das complicações da hipertensão portal já estabelecidas
- Não notificar o caso nem considerar a dimensão de saúde pública/comunitária do achado em área endêmica

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Infectologia · Estação #288 · UBS — Atenção Primária · nível moderado

Diarreia crônica e barriga d’água em morador de área rural endêmica

CHECKLIST — DIARREIA CRÔNICA E BARRIGA D’ÁGUA (ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA)

BLOCO 1 — COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE	Pts	Avaliação
Explicou a relação entre a exposição à água do rio e a doença hepática desenvolvida Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Desconstruiu o medo de câncer expresso pelo paciente Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 2 — ANAMNESE	Pts	Avaliação
Investigou exposição prolongada a águas doces em área endêmica Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou episódios de hematêmese/sangramento digestivo Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 3 — EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Avaliou ascite (macicez móvel) e circulação colateral Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Palpou hepatoesplenomegalia Ministério da Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 4 — RACIOCÍNIO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO	Pts	Avaliação
Solicitou exame parasitológico de fezes (Kato-Katz) Ministério da Saúde	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou endoscopia digestiva alta para rastrear varizes esofágicas Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I

BLOCO 5 — CONDUTA E ORIENTAÇÃO AO PACIENTE	Pts	Avaliação
Prescreveu praziquantel em dose única Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Encaminhou para manejo especializado da hipertensão portal Ministério da Saúde	1	☐ A ☐ P ☐ I
Considerou a dimensão comunitária do achado em área endêmica Ministério da Saúde — Guia de Vigilância em Saúde	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **9,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado